

פרק 26

יתר לחץ דם בהיריון

פרופ' רינת גבאי בן זיו

ד"ר אביטל אנג'ל קורמן

רקע

מחלות יתר לחץ דם (יל"ד) בהיריון מערבות כ-2-8% מכלל הנשים בהיריון, כרוכות בשיעור גבוה של תחלואה אימהית, ומהוות את הגורם השני בחשיבותו לתמותה אימהית בארצות מפותחות. בנוסף הן קשורות בשיעור גבוה של תחלואה ותמותה של עוברים וילודים, בעיקר על רקע של לידה מוקדמת והאטה בגדילה תוך-רחמית. רעלת היריון (preeclampsia) היא גם גורם סיכון לתחלואה קרדיוסקולרית ומחלה מטבולית בשנים מאוחרות יותר אצל האם ואצל היילוד. שיעור רעלת היריון עלה ב-25% בשני העשורים האחרונים.

ניתן לחלק את תחלואת ל"ד בהיריון לנשים עם יל"ד כרוני (שאובחן טרם ההיריון) או לנשים המפתחות לראשונה יל"ד לאחר שבוע 20 להיריון.

נשים עם יתר ל"ד כרוני או היריוני הינן בסיכון מוגבר להתפתחות רעלת היריון (superimposed preeclampsia), החמרה בל"ד ופגיעה באברי מטרה (אי ספיקת כליות, בצקת ריאות, אירוע מוחי או לבבי).

נשים עם יל"ד היריוני נמצאות בסיכון דומה לנשים עם רעלת היריון מבחינת תוצאות מילדותיות והשלכות לטווח הרחוק. בנוסף, לפחות 50% מהנשים עם יל"ד היריוני יפתחו רעלת היריון, בעיקר אם האבחנה נעשתה לפני שבוע 32 להיריון. על כן מקובל להתייחס ליל"ד היריוני כאל רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים.

הגדרות - סוגי לחץ דם בהיריון

יתר ל"ד כרוני בהיריון

אבחנה של יל"ד קודמת להיריון או ערכי ל"ד שווים או עולים על ערך סיסטולי של 140 ו/או דיאסטולי 90 מ"מ כספית לפני שבוע 20 להיריון או יל"ד שנמשך גם לאחר משכב הלידה (לאחר 12 שבועות מהלידה). לצורך מעקב ואבחון של יל"ד כרוני ניתן לבצע ניטור ל"ד ביתי (עצמוני) או הולטר לחץ דם של 24 שעות.

יתר ל"ד היריוני

מידת ל"ד שווה או מעל ערך סיסטולי של 140 ו/או דיאסטולי 90 מ"מ כספית המופיעה לראשונה לאחר שבוע 20 להיריון או במשכב לידה, ושאינה מלווה בפרוטאינוריה או באחד המאפיינים החמורים של רעלת היריון (מפורט בהמשך). מומלץ כי אבחנה של יל"ד תתבצע על סמך שתי מדידות נפרדות בהפרש של 4 שעות לפחות, למרות שלעתים אין אפשרות להמתין פרקי זמן אילו.

יל"ד נחשב חמור (בין אם כרוני או היריוני) אם מדידות ל"ד מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי, מ"מ כספית.

פרוטאינוריה

מהווה חלק מהקריטריונים לאבחנה של רעלת היריון ומוגדרת כהפרשת חלבון בשתן מעל 300 מ"ג ל-24 שעות או יחס חלבון/קראטינין בשתן של 0.3 ומעלה (ביחידות של מ"ג לדציליטר כל אחד מהם). רצוי להימנע משימוש בתבחין שתן מרפאתי (בדיפסטיק) לאבחנה, אולם במידה ואין אפשרות למדידה אחרת, נוכחות של +2 חלבון בשתן בבדיקת דיפסטיק תחשב כחשד לפרוטאינוריה.

Superimposed preeclampsia

מוגדרת כהופעת רעלת היריון בנשים עם יל"ד כרוני. יש לחשוד ב-superimposed preeclampsia במצבים הבאים:

- עלייה פתאומית בלחצי הדם שהיו מאוזנים או צורך בהעלאת מינון תרופתי כדי לאזן את לחץ הדם
- הופעה חדשה של פרוטאינוריה או החמרה בפרוטאינוריה קיימת
- הופעת אחד מתסמיני רעלת עם מאפיינים חמורים (מפורט בהמשך)

Preeclampsia - רעלת היריון:

תסמונת ייחודית להיריון ו/או למשך הלידה המתבטאת לאחר שבוע 20 להיריון ומתאפיינת ע"י הופעה חדשה של יל"ד ופרוטאינוריה או יל"ד בצירוף לפחות מאפיין חמור אחד של רעלת היריון (כמפורט בהמשך).

נהוג לחלק את הרעלת לשני סוגים - מוקדמת (לפני שבוע 34) ומאוחרת (שבוע 34 ומעלה). מרבית מקרי הרעלת הינם לקראת המועד (רעלת מאוחרת) אולם עיקר התחלואה האימהית והעוברית נובעת מרעלת מוקדמת.

הפתוגנזה של רעלת אינה ודאית אך התיאוריות המובילות קשורות באיסכמיה שליתית על רקע בעיה בהשרשת הטרופובלסט בדופן הרחם ותהליך ה-remodelling של העורקים הספירליים משולבת בהפרעה באיזון הפקטורים האנגיוגנים והאנטי-אנגיוגנים (sFLT-1 ו-PlGF) עם או ללא רקע של הפרעה קרדיווסקולרית אימהית תת-קלינית. תיאוריות אחרות קשורות באי התאמה אימונית, גנטית, תגובה אימהית דלקתית (אינפלמטורית) ועוד.

רעלת היריון עם מאפיינים חמורים:

- יתר ל"ד גבוה או שווה לסיסטולי של 160 ו/או דיאסטולי של 110 מ"מ כספית בשתי מדידות בפער של 4 שעות לפחות (התייחסות למדידה בודדת של יתר ל"ד מעל ערכי הסף הינה לפי שיקול קליני).
- כאב ראש שאינו מגיב לטיפול תרופתי וללא הסבר אחר או טשטוש ראייה חדש
- כאב חזק ממושך ברום הבטן שלא מגיב לטיפול ושאינו נובע מסיבה אחרת
- ירידה ברמת הטסיות (טרומבוציטופניה) מתחת ל-100,000 לממ"ק (בהיעדר סיבה אחרת לטרומבוציטופניה)
- עלייה באנזימי כבד (מעל פי 2 מהגבול העליון של הנורמה, ללא הסבר אחר)
- הפרעה בתפקודי כליה (קראטינין מעל 1.1 מ"ג לדציליטר או הכפלתו בהיעדר מחלת כליה אחרת)
- בצקת ריאות
- HELLP syndrome: תסמונת הכוללת הפרעה מעבדתית משולבת: המוליזה, עלייה באנזימי כבד וירידה בטסיות. תסמונת HELLP קשורה בתחלואה ותמותה אימהית. הגדרה כוללת: רמת LDH מעל 600 יחידות לליטר, עליה ב-AST ו-ALT מעל פי 2 מהנורמה, וירידה בטסיות מתחת ל-100,000 לממ"ק. תסמונת HELLP יכולה להופיע באופן מלא או חלקי, במהלך ההיריון או לאחר לידה, ובנוכחות או בהיעדר מאפיינים אחרים של רעלת היריון.

אקלמפסיה:

פרקוס מסוג grand-mal ו/או אובדן הכרה, שאינו קשור להפרעה אחרת במערכת העצבים המרכזית. הפרקוס יכול להופיע כהסתמנות ראשונה של רעלת ללא יל"ד או פרוטאינוריה מקדימה או בעקבות תלונות מבושרות לפני, במהלך או לאחר הלידה. שיעור נמוך של הנשים עם רעלת היריון יפתחו אקלמפסיה.

נשים לאחר אקלמפסיה הין בסיכון להופעת Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) - סינדרום הכולל בנוסף לערכי לחץ דם מוגברים גם מנעד של הסתמנות נוירולוגית כמו הפרעות ראייה, בלבול, כאבי ראש ועוד. אבחנה של PRES נעשית ב-MRI.

אבחנה מובדלת של PRES כוללת Reversible cerebral vasoconstriction syndrome והטיפול בשני המצבים כולל איזון יתר ל"ד, טיפול אנטי אפילפטי ומעקב נוירולוגי.

טיפול במחלות יתר לחץ דם בהיריון:

הערכה טרום הריונית

רצוי כי נשים עם יל"ד ארוך שנים יעברו הערכה טרום הריונית לצורך מתן מידע על סיבוכים בהיריון, התאמת טיפול (לדוגמה הפסקת תרופות מסוג מעכבי ACE או ARBs - Angiotensin II receptor blockers), איון יל"ד טרם להיריון והפחתת גורמי סיכון נוספים.

כמו כן מומלץ להשלים הערכה קרדיאלית ובירור אברי מטרה (הערכת סימני רטינופתיה היפרטנסיבית והערכה כלייתית) טרם ההיריון בתלות בחומרת ומשך היל"ד.

מעקב היריון

מעקב היריון יכלול את כל בדיקות הסקר המקובלות במידה ולא בוצעו טרם ההיריון או ע"פ משך הזמן מהערכה קודמת ושיקול קליני (הערכה קרדיאלית ובירור אברי מטרה - סימני רטינופתיה היפרטנסיבית והערכה כלייתית).

הערכה כלייתית תכלול רמת קריאטינין עם יחס חלבון/קריאטינין או איסוף שתן לחלבון 24 שעות.

מומלץ מעקב ל"ד והתאמת טיפול תרופתי טרם להיריון או בתחילתו.

ערכי היעד ותדירות מעקב ל"ד ייקבעו בהתאם לגורמי הסיכון ולנוכחות פגיעה באברי מטרה. עבודות שפורסמו בשנים האחרונות הצביעו על יתרון באיון יל"ד כרוני עד לערכי מטרה נמוכים מ-140 מ"מ כספית סיסטולי ו-90 מ"מ כספית דיאסטולי ללא עלייה בתוצאים שליליים (האטה בגדילת עובר), בפרט אם הטיפול הותחל לפני שבוע 20 להיריון. עם זאת, מרבית הנשים ההרות עם יל"ד כרוני לא נדרשות לטיפול אנטי היפרטנסיבי במהלך ההיריון.

תכשירים מקובלים לטיפול ביל"ד כרוני בהיריון מופיעים בטבלה 1.

טיפול באספירין במינון 100-150 מ"ג הוכח כמפחית סיכון לרעלת היריון בנשים עם אבחנה של יל"ד כרוני. מומלץ להתחיל את הטיפול באספירין לקראת סוף השליש הראשון ובעדיפות להתחלת טיפול לפני שבוע 16-20 להיריון.

מעקב ההיריון יכלול מעקב אחר סימני הופעת superimposed preeclampsia. יש לתדרך את היולדת להופעת תלונות מבשרות ולהמליץ על מעקב ל"ד, מעקב פרוטאינוריה (בדיקות סטיק חלבון בשתן) ומעקב גדילת עובר.

ניהול superimposed preeclampsia

מעקב אחר נשים עם superimposed preeclampsia כולל מעקב אימהי ומעקב עוברי. החלטה על אשפוז או מעקב אמבולטורי וכן תדירות המעקב תלויה בהערכה האינדיבידואלית ובשיקולים קליניים. מעקב אימהי כולל הדרכה להופעת תלונות מבשרות רעלת, מעקב ל"ד, ומעקב מעבדתי (ספירת דם וכימיה כולל אנזימי כבד). מעקב עוברי כולל מדדי גדילת עובר עם או ללא זרימות דופלר ע"פ הצורך וכן מדדים אקוטיים כולל מעקב תנועות עובר, פרופיל ביופיסיקלי וניטור עוברי.

במידה והופעת מאפיינים חמורים - ההתייחסות תהיה כאל רעלת היריון עם מאפיינים חמורים.

אופן ומועד ילוד במידת הצורך

אופן היילוד ייקבע ע"פ גיל ההיריון והמאפיינים המיילדותיים.

יל"ד כרוני מאוזן - יילוד מקובל בין שבוע 37+0/7 לשבוע 39+6/7 כתלות בשיקול דעת קליני.

superimposed preeclampsia ללא מאפיינים חמורים - הספרות מצביעה על יתרון בניהול שמרני עד שבוע 37. החלטה על הקדמת מועד ילוד לפני שבוע 37 תעשה על פי שיקול דעת קליני

superimposed preeclampsia עם מאפיינים חמורים - בדומה לניהול רעלת היריון עם מאפיינים חמורים. אין מניעה מניהול שמרני עד שבוע 34+0 בדומה להגדרות המקובלות עבור ניהול רעלת היריון עם מאפיינים חמורים.

ניהול רעלת היריון

רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים או יתר ל"ד הריוני

אין הוכחה חד משמעית בספרות ליעילות טיפול להורדת יל"ד בנשים עם רעלת ללא מאפיינים חמורים או יתר ל"ד הריוני ולחצי דם מוגברים מתחת לסף של 160 מ"מ כספית סיסטולי או 110 מ"מ כספית דיאסטולי.

עם זאת, לאור עבודות המרמזות על הורדת שיעורי יל"ד חמור ללא עלייה בתופעות לוואי ניתן לשקול מתן טיפול להורדת יל"ד גם בנשים אלה לאחר שקילת יתרונות וחסרונות ותוך התחשבות במאפייני היולדת והסיכון להתקדמות לרעלת עם מאפיינים חמורים.

אפשרויות מקובלות, אם כי לא בלעדיות, לטיפול תרופתי מופיעות בטבלה 1.

הספרות מצביעה על יתרונות בניהול שמרני של רעלת היריון ללא מאפיינים חמורים או יתר ל"ד הריוני עד שבוע 37. החלטה על הקדמת מועד ילוד לפני שבוע 37 תעשה על פי מאפיינים אינדיבידואליים ושיקול קליני (לדוגמה במצבים של האטה בגדילה תוך רחמית).

במהלך הלידה, בנוכחות לחץ דם סיסטולי מתחת ל-160 מ"מ כספית ודיאסטולי מתחת ל-110 מ"מ כספית, אין צורך במתן שגרתי של מגנזיום סולפט למניעת פרכוסים.

רעלת היריון עם מאפיינים חמורים

שיעור הסיבוכים לאם ולילוד עולה בנוכחות רעלת היריון עם מאפיינים חמורים. סיבוכים אימהיים עלולים לכלול בצקת ריאות, אירוע מוחי או לבבי, אי ספיקת נשימתית, אי ספיקת כליות, הפרעת קרישה ופגיעה עינית. על כן, ביולדת בשבוע 34 ומעלה, במידה ומתפתחת רעלת עם מאפיינים חמורים ההמלצה היא לייצב את היולדת ולילד. אין לעכב לידה לטובת טיפול בסטרואידים בתקופה זו.

נשים לפני שבוע 34 ניתן לנהל שמרנית תוך מעקבי קפדני באשפוז, במידה והיולדת יציבה ואין עדות לקיפוח עוברי. מעקב שמרני אינו מומלץ במקרים הבאים:

- יל"ד לא נשלט שאינו מגיב לטיפול תרופתי חשד משמעותי להפרדות שליה
- מצוקה עוברית על פי מדדי הניטור כתלות בגיל ההיריון.
- תסמונת
- חסר נוירולוגי אימהי או הפרעה קרדיווסקולרית משמעותית (כגון בצקת ריאות)
- אי ספיקת כליות חדשה
- מצבים בהם השהיית הילוד לא צפויה לשפר את הפרוגנוזה העוברית (מום לטלי, לפני גיל חיות, תמותת עובר ברחם).

ייצוב היולדת כולל טיפול להורדת יל"ד (במידה וערכי יל"ד מעל 160 סיסטולי או 110 דיאסטולי מ"מ כספית) ומתן מגנזיום סולפט למניעת פרכוסים.

אפשרויות מקובלות לטיפול תרופתי לצורך הורדה דחופה של יתר ל"ד בהיריון מופיעות בטבלה 2.

מגנזיום סולפט בטפטוף לווריד היא תרופת הבחירה ברעלת עם מאפיינים חמורים למניעת פרכוסים ומקובל להמשיך בטיפול לפרק זמן של כ-24 שעות לאחר הלידה.

בחלק מהמקרים ניתן לדחות את מועד היילוד ב-48 שעות לצורך מתן קורס סטרואידים לשיפור בשלות העובר כתלות בגיל ההיריון ובחומרת ההסתמנות האימהית והעוברית.

במידה ומתפתח פרכוס יש לשקול הדמייה מוחית.

יילוד בנשים עם רעלת היריון

אופן היילוד ייקבע ע"פ גיל ההיריון והמאפיינים המיילדותיים. רעלת היריון אינה מהווה התוויה כשלעצמה לניתוח קיסרי.

אלחוש בלידה: השימוש באלחוש אזורי במהלך הלידה או בניתוח קיסרי בנשים עם רעלת היריון הוא בטוח ויעיל ובמרבית המקרים אף עדיף על הרדמה כללית.

הסתמנות ראשונה של רעלת היריון במשכב הלידה

הספרות על רעלת המסתמנת לראשונה במשכב בלידה מוגבלת. עם זאת מקובל להגדירה כרעלת המופיעה לראשונה החל מ-48 שעות ועד שישה שבועות לאחר לידה.

רעלת היריון המסתמנת לראשונה במשכב הלידה מאפיינת נשים עם גיל אימהי מבוגר יותר, עם הסתמנות קלינית של יל"ד וכאבי ראש ולא דווקא פרוטאינוריה או שינויים מעבדתיים.

לנשים אלה סיכון מוגבר לפרקוס ביחס לנשים עם רעלת שהתפתחה במהלך ההיריון ולכן יש לשקול בחיוב מתן מגנזיום סולפט במקביל להורדת יל"ד וטיפול תומך.

טיפול ביתר לחץ דם במשכב לידה

בנשים עם יל"ד כרוני תיתכן ירידת ערכי ל"ד בימים הראשונים עם עלייה ב-3-6 ימים לאחר מכן. על כן מומלץ מעקב ל"ד הדוק לפחות 10 ימים לאחר לידה (ניתן אמבולטורית).

בנשים עם יתר ל"ד מתמיד במשכב הלידה, סיסטולי 150 מ"מ כספית או יותר, ודיאסטולי 100 מ"מ כספית או יותר, בשתי מדידות במרווח של 4-6 שעות ביניהן, יש לשקול טיפול אנטיהיפרטנסיבי.

אין מניעה מהנקה בנשים עם יתר ל"ד. אמנם רוב התרופות האנטי היפרטנסיביות ניתנות לגילוי בחלב האם, אך לרוב בריכוז נמוך. תכשירים מסוג חסמי תעלות סידן (אמלודיפין, ניפדיפין) ומתיל דופה (אלדומין) נחשבים בטוחים, עם רמות נמוכות מאוד בחלב האם. חלק מהתכשירים ממשפחת חוסמי הביתא נמצאים בריכוז גבוה בחלב האם (אטנולול, מטופרולול) וחלקם בריכוז נמוך יותר (פרופרנולול ולבטולול).

השימוש בקפטופריל ואנלפריל (מעכבי ACE) נחשב בטוח גם כן בהנקה, עם ריכוז נמוך בחלב האם. במידה ומוחלט על טיפול בתכשירים מסוג מעכבי ACE או ב-ARBs (Angiotensin II receptor blockers) יש להסביר ליולדת כי יש להחליף את הטיפול טרם ההיריון הבא.

המלצות למעקב אחר אישה עם יתר ל"ד כרוני

מומלץ המשך מעקב ל"ד ואיזון תרופתי ע"י הרופא המטפל.

לנשים שפיתחו רעלת היריון עם מאפיינים חמורים אשר חייבה יילוד לפני שבוע 34 מומלץ לבצע ברור של קרישיות יתר נרכשת בתום משכב הלידה (LAC APLA).

מקורות:

1. Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin, Number 222. *Obstet Gynecol.* 2020 Jun;135(6):e237-e260
2. ACOG. Task Force on Hypertension in Pregnancy - Hypertension in Pregnancy. The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2013.
3. Magee LA, Brown MA, Hall DR, Gupte S, Hennessy A, Karumanchi SA, Kenny LC, McCarthy F, Myers J, Poon LC, Rana S, Saito S, Staff AC, Tsigas E, von Dadelszen P. The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens.* 2022 Mar;27:148-169.
4. O'Gorman N, Wright D, Syngelaki A, Akolekar R, Wright A, Poon LC, Nicolaides KH. Competing risks model in screening for preeclampsia by maternal factors and biomarkers at 11-13 weeks gestation. *AJOG* 2016, 214; 103e1-12.
5. Zeisler H, Llurba E, Chantraine F, Vatish M, Staff AC, Sennström M, Olovsson M, Brennecke SP, Stepan H, Allegranza D, Dilba P, Schoedl M, Hund M, Verlohren S. Predictive Value of the sFlt-1:PIGF Ratio in Women with Suspected Preeclampsia. *N Engl J Med.* 2016 Jan 7;374(1):13-22.
6. Poon LC, Magee LA, Verlohren S, et al. A literature review and best practice advice for second and third trimester risk stratification, monitoring, and management of pre-eclampsia: Compiled by the Pregnancy and Non-Communicable Diseases Committee of FIGO (the International Federation of Gynecology and Obstetrics). *Int J Gynaecol Obstet.* 2021;154 Suppl 1(Suppl 1):3-31.
7. Garovic VD, Dechend R, Easterling T, et al. Hypertension in Pregnancy: Diagnosis, Blood Pressure Goals, and Pharmacotherapy: A Scientific Statement From the American Heart Association [published correction appears in *Hypertension.* 2022 Mar;79(3):e70]. *Hypertension.* 2022;79(2):e21-e41.
8. Rolnik DL, Wright D, Poon LC, O'Gorman N, Syngelaki A, de Paco Matallana C, Akolekar R, Cicero S, Janga D, Singh M, Molina FS, Persico N, Jani JC, Plasencia W, Papaioannou G, Tenenbaum-Gavish K, Meiri H, Gizurason S, Maclagan K, Nicolaides KH. Aspirin versus Placebo in Pregnancies at High Risk for Preterm Preeclampsia. *N Engl J Med.* 2017 Aug 17;377(7):613-622.
9. Irgens HU, Reisaeter L, Irgens LM, Lie RT. Long term mortality of mothers and fathers after pre-eclampsia: population based cohort study. *Bmj* 2001, 323:1213-1217.
10. Chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ish.org.il/images/hbp-guides2019.pdf
11. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 203: Chronic Hypertension in Pregnancy. *Obstet Gynecol.* 2019 Jan;133(1):e26-e50.
12. Tita AT, Szychowski JM, Boggess K, et al. Treatment for Mild Chronic Hypertension during Pregnancy. *N Engl J Med.* 2022;386(19):1781-1792.
13. Magee LA, von Dadelszen P, Rey E, et al. Less-tight versus tight control of hypertension in pregnancy. *N Engl J Med.* 2015;372(5):407-417.
14. Webster LM, Conti-Ramsden F, Seed PT, Webb AJ, Nelson-Piercy C, Chappell LC. Impact of Antihypertensive Treatment on Maternal and Perinatal Outcomes in Pregnancy Complicated by Chronic Hypertension: A Systematic Review and Meta-Analysis. *J Am Heart Assoc.* 2017;6(5):e005526.

15. Abalos E, Duley L, Steyn DW, Gialdini C. Antihypertensive drug therapy for mild to moderate hypertension during pregnancy. Cochrane Database Syst Rev. 2018;10(10):CD002252. Published 2018 Oct 1.

16. Metz TD, Kuo HC, Harper L, et al. Optimal Timing of Delivery for Pregnant Individuals With Mild Chronic Hypertension. Obstet Gynecol. 2024 Jul 17.

נספח - תרופות להורדת ל"ד בהיריון

טבלה 1: תכשירים להורדת ל"ד מקובלים לשימוש בהיריון

תכשיר	מינון	הערות
Labetolol	100-2400 מ"ג ליום, פומי, מחולק ל 2-3 מנות	הפעלת שיקול דעת בנוכחות מחלת לב פעילה, דופק איטי, ו/או אסטמה.
Nifedipine	30-120 מ"ג ליום, פומי, של תכשיר עם שחרור מושהה, או מינון מחולק ל 3-4 פעמים בתכשיר קצר טווח	אין להשתמש תת- לשוני
Methyldopa	0.5-3 גרם ליום, מחולק ל 2-3 מנות	יתכן ופחות יעיל במצבים של יתר ל"ד משמעותי

טבלה 2: תכשירים נוגדי יתר לחץ דם לצורך הורדה דחופה של יתר ל"ד בהיריון*

תכשיר	מינון	הערות
Labetolol	mg IV, then 20-80 mg every 20-30 10-20 min to maximum dose of 300 mg or Continuous infusion IV 1-2mg/min	הפעלת שיקול דעת בנוכחות מחלת לב פעילה, דופק איטי, ו/או אסטמה.